

Physioguide — Clínica — Inestabilidad carpiana (SL y LT)

AlKinora / Physioguide es orientativo: no sustituye criterio clínico ni diagnóstico presencial. Ningún test aislado confirma diagnóstico. No se inventan sensibilidad, especificidad ni likelihood ratios. Si la evidencia es mixta o procede de una sola serie, el texto lo indica.

Status: ACTIVE (Phase 1)

Evidence: Watson, ballottement SL/LT, Reagan, Kleinman; cluster C

Principles: Master clinical document

1. DEFINITION

Inestabilidad carpiana = fallo de ligamentos intrínsecos (escafolunar SL o lunopiramidal LT) que altera la cinética de las filas del carpo. Puede evolucionar a colapso (SLAC) si se ignora.

No es De Quervain. No es “esguince inespecífico” si hay clunk dorsal central o cubital con shear.

2. SL (ESCAFOLUNAR)

Historia: FOOSH, carga, click dorsal, debilidad de carga.

Localización: dorso central de muñeca (intervalo SL).

Cluster:

DOLOR DORSAL SL

+ WATSON / SCAPHOID SHIFT

± BALLOTEMENT SL

! SL COMPATIBILITY !

Regla de seguridad: tabaquera + FOOSH ! RX de escafoides primero. No hacer Watson agresivo sobre fractura oculta.

3. LT (LUNOPIRAMIDAL)

Historia: dolor cubital dorsal, menos “fóvea pura” que TFCC.

Cluster: ballottement LT + Reagan + Kleinman shear + palpación intervalo LT.

Diferencial con TFCC: TFCC duele más en fóvea/press/giro; LT más en cizalla ósea dorsal cubital. Pueden coexistir.

4. IMAGING

- RX: diástasis SL (Terry-Thomas), disociación, inestabilidad estática
 - RMN/artroscopia si clínica persistente y RX no concluyente
 - No diagnosticar SLAC en lenguaje de app; «compatible con inestabilidad, precisa valoración e imagen»
-

5. AI RULES

- Watson positivo “” rotura SL confirmada (laxitud, técnica).
- Watson negativo no excluye.
- Dolor cubital “” siempre TFCC (incluye LT y ECU).
- No inventar Sn/Sp de Watson.

Citation: Watson et al. *J Hand Surg Am.* 1988. Reagan LT sprains. Revisiones SLAC/SNAC (JHS).

